Trauma dentoalveolar y lesiones de tejidos blandos

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para trauma dentoalveolar y lesiones de tejidos blandos, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Documento condicional: activar únicamente si la actividad se oferta y reúne requisitos.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Valoración y preparación

Confirmar momento, mecanismo, dentición, localización, lesiones asociadas, dolor y condición general. Valorar aspiración, lesión craneal o fractura maxilofacial que requiere urgencia.

Ejecución segura

Usar guía específica para fractura, luxación o avulsión. No reimplantar diente temporal avulsionado. Para permanente, la conducta depende de tiempo, almacenamiento y contexto; seguir guía completa vigente y competencia, sin fórmula universal.

Seguimiento y remisión

Registrar imágenes justificadas, tratamiento, educación y cronograma por lesión. Coordinar remisión y vigilancia de secuelas.

Implementación

Anexar guía o manual técnico completo, definir técnica, materiales, profesional competente y criterios locales. Aplicar consentimiento específico y registrar cada procedimiento; este protocolo organiza el proceso y no reemplaza formación ni instrucciones de uso.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Condiciones de entrada

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

Decisión y preparación

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

Registro de ejecución

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

Cierre y seguimiento

Establecer instrucciones, señales de alarma, control, resultados pendientes y responsable. Si remite, documentar destinatario, prioridad y recepción cuando procede. Ante falta de seguimiento, utilizar contacto seguro y registrar barreras, sin divulgar datos a terceros no autorizados.

Auditoría clínica

Revisar correspondencia entre diagnóstico, guía, procedimiento, consentimiento, evolución y seguimiento. La revisión no cambia el registro original; una corrección se hace por adenda identificable. Separar indicadores de calidad de datos personales y comprobar acciones de mejora.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-PP13 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://iadt-dentaltrauma.org/guidelines-and-resources/guidelines/

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.